

Mirror exposure *lustro bez oceny*

Strukturyzowana technika pracy z obrazem ciała. 30–45 min w lustrze pełnowymiarowym, opis neutralny (NIE ocena). Hilbert & Tuschen-Caffier 2004 RCT: $d = 0,9$. Wymaga szkolonego terapeuty.

CZAS: 30–45 min · sesja terapeutyczna · Etap 3 CBT-E (sesje 12–16) · zaawansowane

ŹRÓDŁO: Hilbert & Tuschen-Caffier (2004); Delinsky & Wilson (2006)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **cztery cele** mirror exposure (sekcja 1), **sześć elementów protokołu** (sekcja 2). Sekcja 3 — przeciwwskazania. Sekcja 4 — przygotowanie do sesji.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Ekspozycja lustrzana (*mirror exposure*, ME) to **strukturyzowana technika** pracy z obrazem ciała — klient ogląda się w lustrze pełnowymiarowym przez 30–45 minut, opisując *neutralnie* (bez ocen) każdą część ciała. Cele: habituacja lęku, redukcja selektywnej uwagi, przełamanie unikania, neutralny opis. Hilbert & Tuschen-Caffier (2004) RCT: **istotny spadek** niezadowolenia z ciała, epizodów, obaw o kształt ($d = 0,9$). Mirror exposure **wymaga szkolonego terapeuty** — źle przeprowadzona może zaszkodzić. *Nie* u osób z niskim BMI, świeżą traumą, lub w ostrej fazie. Delinsky & Wilson (2006): efekty utrzymują się rok po terapii. Najczęstszy format: 6–12 cotygodniowych sesji.

01 ● Cztery cele mirror exposure

1 · HABITUACJA LĘKU

Wytrzymanie 30–45 min uczy mózg, że lęk *opada sam z siebie*. Każda sesja osłabia siłę unikania ciała.

2 · REDUKCJA SELEKTYWNEJ UWAGI

Patrzeć na *całe* ciało, nie tylko „problematyczne” części (brzuch, uda, biodra). Trening pełnego widzenia.

3 · PRZEŁAMANIE UNIKANIA

Pacjenci z BN często unikają luster lub patrzą tylko ukradkowo. ME przywraca *kontakt wzrokowy* z własnym ciałem.

4 · NEUTRALNY OPIS

Trening języka *opisowego* (kolor, kształt, faktura) zamiast *oceniającego* („brzydkie, grube, ohydne”). Przesunięcie poznawcze.

02 ≡ Sześć elementów protokołu

1 · CAŁA POSTAĆ

Lustro pełnowymiarowe, widok od stóp do głów. Strój dopasowany lub bielizna — bez chowania ciała pod luźnymi ubraniami.

2 · 30–45 MINUT

Długa ekspozycja jest *warunkiem* habituacji. Krótkie spojrzenia wzmacniają lęk. Czas mierzony — nie skrcaj.

3 · OPIS OBIEKTYWNY

„Kolor skóry: bladoróżowy. Kształt ramion: zaokrąglone. Włosy: ciemne, do ramion”. **NIE** ocena. Tylko fakty.

4 · WSZYSTKIE PARTIE CIAŁA

Nie tylko „złe” miejsca. Twarz, włosy, ramiona, dłonie, brzuch, biodra, uda, stopy. Trening pełnego widzenia.

5 · TOLERANCJA EMOCJI

Lęk, smutek, złość — mogą się pojawić. Terapeuta wspiera, ale *nie* ucieka od ekspozycji. Emocje opadają w trakcie sesji.

6 · 6–12 COTYGODNIOWYCH SESJI

Standardowy format. Efekty kumulatywne — każda sesja osłabia siłę unikania i wzmacnia neutralny opis.

03 ✕ Przeciwwskazania i rozważania

PRZECIWWSKAZANIA

- Niski BMI (anoreksja, niedowaga)
- Świeża trauma seksualna lub przemoc
- Ostra faza objawów (epizody > 1×/dzień)
- Wysoka suicydalność
- Brak szkolonego terapeuty

WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY

- Stabilna faza CBT-E (etap 3, sesje 12+)
- Wprowadzona redukcja body-checkingu
- Wprowadzona ekspozycja na unikane sytuacje
- Świadomy wybór pacjenta
- Możliwość kontynuacji 6–12 tygodni

04 ` Przygotowanie do pierwszej sesji

MOJE OCZEKIWANIA I OBAWY

— co spodziewam się czuć, czego się boję, na co liczę

MÓJ PLAN PO SESJI

— samoopieka, kontakt, aktywność łagodząca; nie wracaj od razu do trudnych obowiązków

Klucz: mirror exposure jest *jedną z najsilniejszych* technik pracy z obrazem ciała — ale jednocześnie **najbardziej wymagającą**. Wymaga szkolonego terapeuty, stabilnej fazy terapii i świadomej zgody pacjenta. Hilbert & Tuschen-Caffier (2004): efekt $d = 0,9$ oznacza, że pacjenci po ME mają *znaczco mniejsze* niezadowolenie z ciała niż pacjenci po standardowej CBT bez ME. Delinsky & Wilson (2006): efekty utrzymują się rok po terapii. Mechanizm jest **analogiczny** do ekspozycji w leczeniu fobii — habituacja przez wytrzymanie dyskomfortu. Co *nie* działa: krótkie spojrzenia w lustro, ocenianie się („*jestem ohydna*”), patrzenie tylko na „*problematyczne*” części. Co działa: długa ekspozycja, opis obiektywny, całe ciało. **Bez szkolonego terapeuty** ME może *pogorszyć* objawy — krytyczne myśli w trakcie ekspozycji bez korekty wzmacniają zniekształcenia. Dlatego ta technika jest *standardowo* zarezerwowana dla sesji terapeutycznych, nie pracy własnej w domu. Praca własna z lustrem powinna być *krótka i funkcjonalna* (ubranie, mycie zębów) — nie ekspozycyjna.